

✍ 소아과 8주차 SUMMARY 공지사항

-이번 주차까지가 장성진 교수님 강의입니다!

[참고]

사상체질 설문조사 : 번호 순서대로 1. 소양 2. 태음 3. 소음인 입니다!

태양인은 배제하셨다고 합니다.

(+ 교수님의 사상 찾는 법!

1. 일단 태양인은 배제한다
2. 설문조사로 가장 적게 나온 번호를 배제하고 남은 2개의 체질이 남긴다
3. 2개의 체질에 맞는 처방 2개를 사용해서 그 사람의 체질을 알아낸다!

7강. 소아의 치료법

I. 내치요법

1) 원칙

- 소아는 臟腑嬌嫩, 形氣未充, 生機蓬勃, 再生強力
- 소아질환은 容易發病, 變化迅速, 易寒易熱, 易虛易實, 臟氣清靈, 易趨于康復 특징
- 변증과 병기를 정확히 파악하여 攻하되 正을 상하지 않게 하고 補하되 滯를 유발하지 않도록 함
- 약물에 대한 반응이 성인에 비해 민감하고 즉각적이므로 처방 용약에 不可呆滯, 不可重墜, 不可壅實이 요구
- “稍呆則滯, 稍重則傷” 補虛와 攻邪에 모두 변화에 맞게 적절한 처방이 요구

소아과 원리 = 노인과 원리

- 소아는 풀과 나무의 싹이 나는 것과 비유, 질병 치료시에도 生生之氣를 도와주어 생체의 건강회복을 유리하게 해야 하며 그 중에 脾胃가 중요
- 모든 大辛大熱, 大苦大寒, 峻猛毒烈之品을 정확히 구별하여 증상에 맞춰 사용
- 특히 虛弱證에 補法을 사용할 때에는 湧체되어 脾胃의 氣에 장애를 주지 않도록 주의 (소도지제와 보약 중에 하나만 고르라면?)

원래 소도지제가 원칙이더라도 임상에서는 보약을 사용할 수도 있음을 염두

- 소아과 임상에서 특별히 주의하여 응용해야 할 약은 斑蝥, 蜈蚣, 洋金花, 商陸, 芫花, 大戟, 甘遂, 烏柏, 蘆薈, 山慈姑, 雷公藤, 馬錢子, 草烏, 牽牛子, 瓜蒂, 蓖麻子, 鴉膽子, 白果, 皂莢, 水蛭, 虎杖, 番瀉葉, 天花粉 등

소아과에서 임상에서 특별히 주의해야할 약 1. 태음인 = 백과 / 2. 소양인 = 천화분

- “雖參芪之輩, 爲性亦偏” 남용이나 장기적인 복용은 불필요

- 明代 萬全 <幼科發揮> “醫藥者, 兒之所以保命者也. 無病之時, 不可服藥. 一旦有病, 必請專門之良老誠忠厚者 ... 如有外感風寒, 則發散之, 不可過汗亡其陽也. 內傷飲食, 則消導之, 不可過下亡其陰也. 小兒易虛易實, 虛則補之, 實則瀉之, 藥必對證中藥, 勿過劑也.(용량과도, 희석을 통한 장기간 과용) 病有可攻者, 急攻之, 不可喜補惡攻, 以夭兒命. 雖有可攻者, 猶不可犯其胃氣也.(양약과 겔포스. 식후복약) 小兒用藥, 貴用和平, 偏寒偏熱之劑不可多服.”

2) 소아의 약용량

1. 약용량 결정의 기준 **악마!**

연령	- 한약의 경우 <u>가장 쉽게 접근하는 방법</u>
체중	- 아주 어린 아기에서는 체중으로 계산하는 용량이 실제 필요 용량보다 너무 적을 수가 있고 반대로 나이가 많거나 비만아인 경우 체중 당 용량을 그대로 적용하게 되면 용량과다가 될 수 있는 단점 - <u>일반적으로 성인 용량을 초과하지 않는 한도 내에서 약 용량을 결정하는 것이 좋으며 비만인 경우 이상 체중을 계산하여 적용</u>
체표면적	- 여러 가지 생리 현상이 체중보다는 체표면적에 비례하기 때문에 약 용량을 결정하는 데는 <u>가장 정확한 지표</u> - 체표면적당 약용량이 알려져 있는 경우, 체표면적 환산표나 공식으로 체표면적을 구하여 약 용량을 계산 - 그렇지 않은 경우 성인 체표면적 1.8 m ² 에 해당하는 성인 용량을 소아의 체표면적에 맞게 환산

2-1) 용량 결정에 영향을 미치는 요인 **악마!**

* 제제의 형태

- 탕제는 환산제에, 외용제제는 내복약물에 비하여 용량을 늘린다.
cf. *흡수속도 탕>=산>환.*유효기한 환>산>탕 *편중도 단방>복합방
- 탕제는 환산제에 비해, 외용제제는 내복약물에 비해 용량을 늘림

* 질병의 경증

- 병세가 심하고 중하면 약력이나 약량을 늘리고 병세가 가벼우면 약력이나 약용량을 줄

인다. (cf.급하면 약해도 써야할수도)

- 병세가 심하고 중하면 약력이나 약량을 늘리고 병세가 가벼우면 약력이나 약용량을 줄임

* 체질의 강약

- 체질이 강하면 약량을 증가시키고 체질이 허약하면 줄이는데 병은 심하고 체질이 약할 경우 扶正치료법을 쓰면 약 용량을 줄일 필요는 없다.
- 체질이 강하면 증량, 허약하면 감량
- 체질 약하고 + 병이 심한 경우 = 扶正의 치료법을 쓰면 감량할 필요 없음

* 연령의 대소

- 일반적으로 연령이 증가함에 따라 약용량을 늘린다.
- 체중과 체표면적을 고려하여 약 용량이 과다하지 않도록 조절해야 한다.
- 일반적으로 연령 증가에 따라 약용량을 늘림
- 체중, 체표면적 고려하여 약용량 과다치 않도록 조절

* 지역의 특성

- 北方의 寒冷한 지역에서는 寒冷藥을 줄여서 쓰고 南方의 溫暖한 지역에서는 寒冷藥을 늘려서 쓴다.
- 북방(한랭한 지역) : 한랭약을 감량
- 남방(온난한 지역) : 한랭약을 증량

* 계절의 특성

- 冬節의 寒冷한 기후 시에는 溫熱藥을 늘려 쓰고 夏節의 炎熱한 기후 시에는 寒冷藥을

가해서 쓴다.

- 겨울철에는 온열약을 증량
- 여름철에는 한랭약을 가할 것

* 경험의 다소

- 경험이 풍부하면 독성이 있는 약물이라도 증상에 맞게 변증하여 약의 용량을 조절하여 쓸 수 있다.
- 경험이 풍부하면 독성약물도 증상에 맞게 변증하여 용량을 조절해 사용 가능함

결국 “因藥制宜, 因^人制宜, 因^地制宜, 因^時制宜” 기출
三因 : 人=성별 연령 체질, 地=환경 지리, 時=계절 기후

+)

1) 약물의 성질

- 大苦 大寒 大辛 大熱한 약물은 적게
- 健脾益氣 消食化滯 補氣補血하는 약물은 증량
- 독성이 있는 약물은 신중히 하고 용량도 소량
- 소량 쓰다가 병정을 보며 약량을 늘리며, 치료의 목적에 도달하면 즉시 중지
- 서적에 언급된 허용량을 참고하는 것이 필요

2) 약물의 작용

- 같은 약물이라도 처방 중에서 君藥은 많게, 佐使藥은 적게

3) 약미의 다소

- 약미가 적거나 단방인 경우는 약의 용량을 증량
- 약미가 많은 처방은 용량을 줄임 (단, 군약으로 쓰는 약은 용량을 늘림)

3) 복용법

- 경구(經口)투여는 소아에서 가장 바람직한 방법으로 소량씩 여러 차례로 진행
- 경구 복용시 소아가 스스로 삼키도록 최대한 노력
- 영유아가 협력하지 않으면 머리와 손을 고정하고, 작은 손가락을 사용해 약을 구강으로 보내며, 설근부에서 다시 천천히 기울여 넣어 저절로 연하시킬 수 있게 하는데, 기도로 들어갈 위험이 있으므로 절대 코를 잡고 복용시키지 말아야 한다.(상황에 따라서 잡을 수도 있음)
- 연하곤란과 의식이 떨어지는 환아의 경우 비위관을 사용
- 소독된 비위관을 비강에서 식도로 삽입하고 위에 이르게 하며 약은 약물을 주사기를 사용해 서서히 비위관 내로 주입
- 湯劑, 沖劑(浸劑콜드브루), 浸膏, 糖漿, 丸劑, 片劑, 散劑 등
- 음식과 같이 투여하는 경우음식의 종류에 따라 영향을 주는 경우도 있지만 약의 맛이나 냄새로 복용이 어려운 경우를 감안하여 적용
- 최신 : 워터젤리(예: 녹용소건중탕)

약맛의 조정

丸, 片, 粉末劑 약물은 먼저 물을 섞어 복용해야 하고 적당량의 당을 더해 복용
꿀(소음) / 초코 글
설탕(태음) / 배 단호박

조청(소양. 엿기름물에 삭힘) / 파인애플 블루베리 딸기

* 억지로 약을 먹는 아이들의 입장의 종류.

- 1) 먹기 싫다.: 몸이 거부 (습담이 많다. 침부항 시술), 마음 거부 (고통 못견딤)
- 2) 짜증난다 : 부모 교육 견해야
- 3) 그냥 다 싫다.: 반항의 이유 찾아야. 예) 부모가 애 취급할 때

너의 약습이 좋아질 때까지 치료 받아야한다. 너에게 달려있다.

1) 복용 횟수

- 7세 이하는 연령과 체중에 따라 분복할 수 있다.
- **학동기(7세 이상) : 2~3회(성인과 동일)**

2) 복용 시간 기출

- 소아의 복용 시간은 **식후 1~2시간 전후**가 일반적

滋補藥, 驅蟲藥, 瀉下藥은 공복시

消食導滯藥은 식후에 바로

安神藥은 취침 전

급성병이나 병이 심하면 시간에 구애 받지 말고 복용

병이 胸膈 이상에 있으면 식후

心腹 이하면 식전

四肢에 있으면 새벽 공복

骨髓에 있으면 포식한 후 밤에 복용

- 대개의 경우 소화 장애가 심한 약물은 식후 즉시 또는 30분 이내
- 일반적인 약물은 흡수율을 높이기 위해 식간, 또는 식후 2시간

3) 복용량 (성인을 1로 기준함) 기출

복용량 (성인=1)	출생~1개월(신생아)	1/6
	1개월~1년(영아)	1/4
	2~3세	1/3 한봉지로 하루
	4~6세	1/2 반봉지씩
	7~9세	2/3
	10~14세	3/4
	14세 이상	1 성인과 동일

(단, 체중과 체표면적으로 산출되는 경우와 비교하여 조절하는 것이 필요함)
(+ 투약 예시)

연령(만)	평균 체중	첩수	cc	포수	복용법
1세 이하	3~10kg	2	40	9	5~20cc씩 수시 분복
2~3세	12~	6~7	40	30	2회/일
4세	15~20kg	8	40~60	30	2회/일
5~6세	20~ 30kg	10	60	30	2회/일
7~8세	30kg 이상	15	90	30	2회/일
9세		18	100	30	2회/일
11세 이후		20	120	30	2회/일

4) 국민건강보험 급여 한약제제 사용량(성인을 1로 기준함)

국민건강보험 급여 한약제제 (성인=1)	6개월 미만	1/5
	6개월~1년 미만	1/4
	1~7세 미만	1/2
	7~11세 미만	3/4

	11세 이상	1 성인과 동일
--	--------	----------

- 급여 한약제제는 필요에 따라 2배까지 증량이 가능하다.

*** 복용기간은? (중요)**

성인 최소1달~3달. (고수들 비난했던 과거 반성)

1달은 온으로 치료가 잘 된 것일 수도 있음

2주 한재는 약효가 부족. => **환자 약효 만족도 저하.**

3달은 컴플레인이 다채로워짐. => **컴플레인 관리**(불만제로 처방실력)가 실력.

3달부터가 자기 실력

***처방과 시스템으로 하루 10회 복용도 가능**

4) 처방의 제형

- 治療 目標에 따라 그 目標에 적합한 劑型의 類型을 선택하여 사용
- 多用되는 類型으로 煎湯을 통한 **湯劑(배불러.휴대불편.)**藥材를 粉末로 만든 **散劑(캡슐화 힘들. 먹기 어려워)**, 粉末로 만든 藥材를 劑型化한 **丸劑(만들기도 먹기도 어려워)**등
- 小兒에게 보다 쉽고 效率的으로 韓藥을 투여하기 위해 治療에 有效한 韓藥 劑型을 다양하게 시도. **엑스제(정관장 스틱)**

1) 湯劑

- 一般湯煎
- 蒸溜湯煎
- **소주법(燒酒法)**
 - 오랜 시간 동안 끓이면서 나오는 수증기를 냉각하여 액화시켜서 복용하는 것
 - 약재중의 가장 맑은 성분이 들어있는 한약
 - '노법(露法)'이라는 방법에 근거하여 무색투명한 한약을 제조한 것
 - 쓴맛이 없어 거부감 없이 복용

약효 : 보신 보음하는 약은 힘들고, 방향성 약재 성분 약간 가능.

2) 散劑

- 휴대가 간편하고 복용 및 복약이 용이
- 약미를 세말하여 물에 타서 복용
- 일반적으로 **발산의 기능을 강화하거나 상초에 작용 목적**

3) 丸劑

- 단일 약제를 분말로 만들어서 꿀이나 물을 사용하여 반죽하여 환의 형태로 제조한 경우
- 일반적으로 **하기의 효능이 있고 하초에 작용 목적**
- **그러나 제일 많이 쓰이는 환제 : 마황환**

4) 기타제제

- 휴대, 보관, 투약의 편의성을 위하여 다양한 제제약 보급
- 분말형, 시럽형, 연조EX형, 액제, 고제형, 흡입제, 약침제 등

5) 특수한 상황

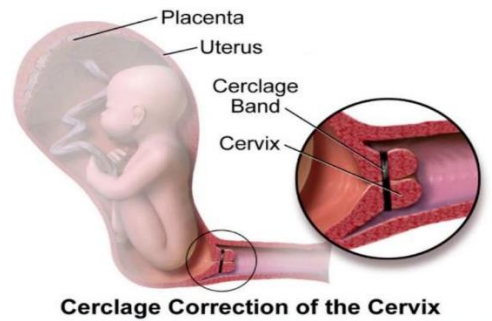
1) 모체의 약물 사용과 수유

- 임신 중에 약물을 사용하는 경우, 태아에게 전달되어 영향을 주는 것과 유사하게 모유 수유를 하는 동안 모체가 약물을 사용하는 경우 모유를 통해 분비되어 유아에 영향
- 따라서 **약물 투여가 꼭 필요한 가를 우선 판단**
- 모체의 질병 치료의 중요성이 우선되어야 하는 경우, 금기인 약물을 사용해야 한다면 모유 수유를 중단할 수밖에 없으나 **일반적으로 사용되는 약물의 경우 모유 수유 중에도 투여가 가능**

- 되도록 수유 중인 유아에게 영향을 덜 주기 위해 수유 직후에 약물을 투여하여 다음 수유까지 체내 약물 농도가 낮아지도록 함

임상례) 하혈하는 임신 5개월. 잦은 유산으로 한약 먹던 환자.

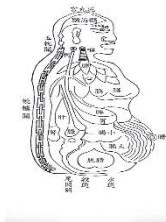
자궁경관무력증과 *원추절제 술과 맥도날드 수술 유산방지 위해 묶어 놓는 것



한의학적 치료원리

調氣治身

- 丹田有三
(상 중 하: 火絳)
- 背有三關
(옥침 녹로 미려: 水昇)



四關과 대맥 그리고 오목

- 수승화강(생리)
- 상열하한(병리)
- 삼전 삼관(포인트)

너무 과학하다가 핵심을 놓치는 사례

<식도염의 원인>

양방 : 갑상선기능저하증의 원인? 신지로이드? 근본 원인?

1. 과식+액상음식 2.자세 3.흉협부 숙열

한의학적 직관 : 원인 파악(간략)

->인체관과 치료원리 바탕으로 치료(총화) + 생활교정 (능동치료제안)

532(아침 점심 저녁식사량의 비율) 30(다작) 30(30분 전에 물마시기 말기) 30(30분 걸어라 눕지 말고!)

2. 외치요법

1) 외치요법

- 內治와 상반된 개념의 용어
- 한의학적인 이론을 바탕으로 약을 복용하는 형식을 취하지 않고 피부나 호흡기 등
- 九竅에 다양한 자극의 방법을 통하여 치료 효과를 유도하는 방법
- 활용범위는 외과질환 치료 중심에서 내과, 외·피부과, 오관과, 부산과, 소아과,
- 신경정신질환에 모두 응용
- 피부염에 연고나 크림을 사용하는 경우 소아의 피부가 성인에 비해 얇고

상대적인 체중 당 체표면적이 크다는 것을 감안하여 약물의 흡수가 항진될 수
있음을 염두에 두어야 하며, 장기간 사용시 전신적 부작용도 고려

Case 아이들을 구해라!

양방 아토피 치료제 : 스테로이드 -> 면역억제제 - 항암제

※ why → how → what을 한의학에 적용

why?

왜 하느냐?

신념. 믿음.

당신이 믿는 것을
믿는 사람들과 일하는 것.
믿는 사람에게 파는 것.

why

우리가 하는 모든 것들,
우리는 기존의 현상에 도전하고 다르게 생각한다는 것을 믿습니다.

우리가 하는 모든 것들,
우리는 기존의 의학을 보완하기위해 다르게 생각한다는 것을 믿습니다.

↓

how

기존의 현상에 도전하는 우리의 방식은
제품을 아름답게 디자인하며
간단히 사용할 수 있고 편리하게 만드는 것입니다.

기존의 의료를 보완하는 우리의 방식은
질병의 근본치료에 도전하며,
간단히 치료과정을 이해하고
적절히 참여하게 만드는 것입니다.

↓

what

우리는 방금 훌륭한 컴퓨터를 만들게 되었습니다. 애플컴퓨터

우리는 방금 수천년간 성숙된 치유철학을 현대기법으로 구현하는 의학을 소개하게
되었습니다. 한국 한의학. k med

- 사람들은 임무를(물건을)구입하지 않는다. 신념을 구입한다.
- 당신이 하는일은 간단하게 당신의 신념의 증거 역할을 한다.

"이끄는 이들은 영감을 준다."

의무가 아니라 바라는 것이기 때문.

"우리 스스로를 위해 따릅니다."

왜와 함께 시작하는 이들은

그들 주변에 영감을 주거나 영감을 주는 이를 찾는 능력이 있습니다.

- 치자떡 어혈제거와 염증완화에 좋은 치자떡 민간요법
발열, 경풍, 감증, 화상

2) 熱熨療法(열위요법) 기출

* 熱熨療法 열위(찜질) 싹뜸방

- 약물에 열을 가하여 처리한 후 인체의 국소부위에 그 熱氣를 다림질하듯 적용하는 치료 방법
- 祛風散寒, 溫經通絡, 鎮痛消腫 등의 작용
- 병의 성질을 변화시키거나 회복능력을 촉진하는 효능

1. 塗敷療法

* 塗敷療法 도부(파스)

- 약물로 탕액을 만들거나 점성이 있는 풀이나 진흙의 형태로 가공하여 인체의 국소부위에 도포하거나 습포를 만들어서 사용하는 치료방법
- 清熱解毒, 理氣活血, 散寒止痛, 去風除濕 등의 효능
- 發熱, 驚風, 疳證, 火傷 등의 병증에 상용

3) 灌腸療法(관장요법)

- 약물을 항문을 통하여 주입하여 질병을 치료하는 방법
- 관장액은 장내에 유지되어 흡수되거나, 대장을 자극하여 대변을 배출

- 保留灌腸 / 直腸滴注(물방울적 부을주)

영유아의 위급한 증상인 발열, 대변폐색, 장꼬임 급성기, 신장질환

* 直腸滴注法(整腸療法)

- 생리식염수와 적정량의 약액을 혼합하고, 관장세트, 소독된 점적관과 rectal tube 및 윤활제를 준비 (약액은 약 40℃ 정도)
- 먼저 환자를 좌측 와위 자세를 취하게 한 다음, rectal tube를 천천히 항문으로 삽입하고 직장에 이르게 하여(일반적으로 6~8cm 깊이) 고정한 후, 점적 밸브를 조절하여 약액을 서서히 주입
- 약액 주입시 손으로 복부를 좌측으로 선회하며 마사지
- 주입하기 전 대변을 보게 하면 더욱 좋음
- 주입 후, 최소 10분 이상 경과 후 환자가 스스로 배변하게 함
- 적용범위가 넓고, 영양제를 제외한, 거의 모든 각종 약물을 직장을 통해 공급 가능
흡수가 빨라 약물공급이 효율적이며, 경구복용 곤란함과 약물의 위 자극을 피할 수 있고,
경구복용시 소화관에서 pH, 효소 등의 영향을 받는 것을 피함. 영유아의 위급한 증상인 발열, 대변폐색 및 장꼬임 급성기, 신장질환 등에 적합

4.藥袋療法 기술

* 藥袋療法(약효 + 사랑)

- 약물을 잘게 부수어 작은 포대에 넣어서 소아가 허리에 차고 다니거나 누워 있을 때 뒷 머리 부위에 놓거나 복부를 덮어서 치료하는 외치방법 (매밀 국화 편백 베개.)
- 장기적으로 사용할 수 있고 선천의 품부부족이나 후천의 영양실조로 인한 허약아의 경우 예방보건의 작용

5.藥浴療法 기술

* 藥浴療法

- 환아가 약물의 탕전액에 환부를 넣거나 전신을 목욕하여 치료하는 방법
- 환부를 약물의 탕전액으로 씻는 과정에서 피부의 혈액순환을 촉진하고 약물을 통과시키므로 피부에 調和氣血, 溫經活絡, 祛除病邪의 작용
- 소아과의 임상에서는 주로 약물을 온천수에 희석하여 침투시키는 방법을 사용

6. 霧化吸入療法(무화흡입요법)

* 霧化吸入療法

- 약물을 안개와 같이 기화시켜서 환자의 호흡기에 흡입시키거나 국소 환처에 접촉시켜 질병을 치료하는 방법
- 호흡기 질환(감모, 해수, 기관지염, 폐렴 등), 피부 질환, 국소성 마비 질환 등에 응용
- 증기흡입법과 초음파 기기를 이용한 흡입법으로 나뉜다.

7. 滴藥療法

* 滴藥療法

- 약물을 끓여서 만든 액체 또는 신선한 약재를 짜서 만든 즙을 환처에 **방울방울 떨어뜨려** 질병을 치료하는 방법
- 眼, 耳, 鼻 등의 질병에 주로 사용
- 感冒, 鼻炎, 急性結膜炎, 扁桃腺炎, 驚風, 中耳炎 등에 사용

8. 貼敷療法

* 貼敷療法

- 고제나 연고로 만들어서 환부에 도포하는 방법
- 積滯, 泄瀉, 喘息, 慢性氣管支炎, 鵝口瘡, 滯頤, 疳腮 등에 사용

* 삼복첩(冬病夏治 三伏貼) ★★★★★★★★★★

- 전통 韓醫學적 치료방법의 한 종류로 鍼灸, 經絡, 韓藥學의 이론이 결합
- 연중 가장 더운 3일에, 膏藥을 背部의 肺俞, 心俞, 膈俞 등 **혈자리에 붙임**
- 三伏일은 일 년 중 가장 더운 三日로 夏至 이후의 셋째, 넷째 庚日과 立秋 이후의 첫째 庚日을 지칭 (初伏, 中伏, 末伏)
- 溫肺散寒, 止咳平喘, 化痰散結, 開竅通絡하는 白芥子, 玄胡索, 甘遂, 細辛, 麝香 등의 韓藥을 사용하여 환약 형태의 약을 생강즙에 적서 첩부
- 冬病夏治 ★기출<11>: 人體 陽氣가 왕성한 시기에 正氣를 돕게 되어, 겨울에 病이 再發하는 것을 예방하며 증상을 완화시키고 발작 횟수를 감소시킴
- 韓藥을 혈자리에 붙이면, 혈자리에 **미세화학적 자극과 熱性 자극**이 가해져서 病을 치료하고 豫防
- 알레르기성 기관지 천식, 알레르기성 비염, 아토피피부염, 재발성 감기 등을 치료하고, 감기의 예방에도 사용
- 經絡 穴位의 피부에 스며들어 病處에 직접 도달하는 방식이어서 **위장관 장애를 감소시킬 수 있으며, 약효가 지속적**
- 약을 먹기 싫어하는 소아와 약을 과다하게 복용하는 노인에게 적용
- **조작이 간편하고 싸며, 통증과 부작용도 없음**
- 성인의 전연령에도 적용이 가능하나 **임산부와 1세 이하 소아에게는 부적합**

9. 吹藥療法

* 吹藥療法

- 약물을 가루로 미세하게 만들어서 바람으로 불어넣어 환부에 도달시켜 치료하는 방법
- 이비인후과 질환의 치료에 주로 사용
- 환처나 점막에 직접 적용할 수 있는데 조직이 약하고 예민한 부위로 약물의 흡수가 빠르고 신속한 효과를 낼 수 있어서 소아의 내과급증에 빠른 효과
- 急性扁桃腺炎, 白喉,(디프테리아) 鵝口瘡, 急性鼻炎, 鼻衄, 急驚風 등에 사용

10. 藥膜療法

* 藥膜療法

- 환부에 약물을 막을 형성하듯 도포하거나 도포한 후 얇은 막을 형성하여 질병을 치료하는 방법
- 얇은 막은 환부의 접착력을 강화하고 안정성이 좋아서 지속시간이 긴 장점
- 口腔潰瘍, 火傷, 疔瘡 (자시.유행성이하선염) 癰腫, 糜 爛性鼻粘膜炎, 角膜潰瘍등에 사용

3. 침구요법

1) 毫鍼療法(호침요법)

- 고대의 구침의 한 종류로 보편적으로 가장 흔히 사용하는 침술방법
- 인체의 대부분의 경혈에 사용할 수 있으며 體鍼療法이라고도 불림
- 소아의 경우 침 치료에 대한 거부감이 있기 때문에 침술을 적용하기 위해서는 숙련된 조작이 필요하고 득기를 파악하기 어렵기 때문에 환아의 상태를 신중하게 살피면서 상황을 확인하는 것이 중요
- 일반적으로 소아에게 침술을 적용할 때는 깊게 찌르지 않는 것을 원칙으로 하며 특히 장기의 손상을 입힐 수 있는 혈위에 주의

2) 三稜鍼療法 (삼릉침요법)

- 삼릉침을 이용하여 소량의 點刺出血을 일으켜 효과를 얻는 침술방법
- 放血療法, 刺血絡療法(고대)
- 開竅, 醒腦, 散熱, 消瘀, 活血의 효능
- 효과가 빠르고 조작이 간편한 것이 특징

- 응급 증상인 **中暑, 急性皮膚炎, 驚風, 外感頭痛, 咽痛** 등에 적용
- 혈액이 노출되므로 엄격한 멸균상태를 유지, 감염 예방
- 시술부위의 동맥을 피함
- 血腫이 생긴 경우 부항을 사용하여 제거
- 훈침이 발생한 경우 즉시 지혈을 시키고 처치를 진행

3) 皮膚鍼療法 (피부침요법)

- 여러 개의 침으로 구성된 피부침을 淺刺하여 皮膚에 약간 刺戟을 주는 침술 방법
- **매화침요법**
- 치료부위의 경락순행과 신경, 근육의 분포를 고려하여 상에서 하로 또는 바깥쪽에서 안쪽으로 순서를 정하여 시술
- 소아의 **복통, 설사, 식욕부진, 心悸** 및 기타 **피부질환**에 유용
- 시술하려는 피부를 충분히 소독하여 감염을 예방
- 국소 피부에 창상 또는 궤양이 있는 경우는 사용 불가

4) 藥鍼療法 (약침요법)

- 經絡學說의 원리에 의거하여 약물을 선택해서 有關한 穴位, 壓痛點 혹은 體表의 觸診으로 얻어진 양성 反應點에 注入하여 刺針과 藥物作用을 통해 인체의 기능을 조절하고 병리 상태를 개선시켜 질병을 치료하는 療法

- 일정한 韓藥을 원료로 하여 다양한 抽出 과정을 거쳐 만든 제제를 주사기를 이용해 직접 인체의 經穴, 皮下, 肌肉, 靜脈 등에 주사하여 질병을 치료하는 침술 방법
- 개별 약침액의 작용, 용량, 금기, 부작용 등을 숙지하여 시술
- 이상 반응이 의심되는 경우는 미리 피부반응검사를 실시하여 그 유무를 가림
- 손상이나 이상을 초래하지 않는 범위에서 신중하게 진행

*봉침 소양인 주의.

5) 電針療法 (전침요법) 기출

- 호침을 시술한 후 침에 미량의 전류를 흐르게 하여 일정기간 자극을 줌으로써 침과 전기의 종합적인 작용을 이용하는 침술 방법 **내장동통, 신경통, 소아마비, 뇌염후유증 등의 완고한 난치성 질환**에 응용
- 전침기의 정확한 사용법을 숙지하여 안전사고를 예방하기 위한 적절한 대처 방법을 익힘
- 근육수축이 강력하게 일어나는 경우 暈鍼, 彎鍼, 切鍼 등이 일어날 수 있으므로 환아의 상태를 면밀히 관찰
- **심장병**이 있는 소아의 경우 사용에 **신중을 기함**

6) 頭鍼療法 (두침요법)

- 大腦皮質區의 기능과 연관시켜 頭皮의 상응 부위에 자침하여 질병을 치료하는 침술 방법

東洋醫學의 刺針方法을 大腦皮質區의 기능과 연관시켜 頭皮의 상응 부위에 자침하여 질병을 치료하는 침술방법

- 신경계통질환인 중풍후유증, 마비에 효과적이며 심혈관계 질환, 유뇨증, 담마진 등에 일정한 효과 있음.

신경계 마비성 질환, 뇌성마비, 발달장애에 효과적이다.

- 高血壓, 急性 腦出血疾患, 頭部 개방창상, 천문 불유합시는 시술을 禁

- 두피에는 혈관이 풍부하여 출혈이 자주 발생하므로 스폰지로 발침부위에 압박을 가하여 지혈

7) 耳鍼療法 (이침요법)

- 인체에 상응하는 耳廓에 자침하여 인체 각부 질병을 치료하는 침술요법
- 東洋醫學의 臟象論, 經絡學說과 서양의학의 해부생리학을 결합된 치료방법
- 인체의 臟腑나 肢體에 병변이 발생하면 耳廓上의 일정한 상응부위에 압통, 피부전기저항 저하, 變色, 充血, 丘疹, 水泡, 皮膚, 小硬結, 색소침착 등 반응현상이 나타나 이 敏感點에 자침하여 치료 효과를 이끌어냄

- 耳廓은 외부로 노출되어 있기 때문에 쉽게 감염과 손상의 우려가 있으므로 시술 전 철저한 감염관리가 필요

- 동상이나 화상을 입은 경우에는 금함

8) 腕踝鍼療法 (완과침요법)

- 全身을 양쪽으로 세로로 縱割하여 이를 여섯 區域으로 나누고 橫隔膜을 경계로 上下를 정하여 疾病이 나타나는 구역을 정확하게 觀察査定하여 여기에 대응해서 相應하는 腕踝部位에 각각 6點의 刺入點을 選擇하여 刺鍼(水平刺)하여 鍼感(酸·麻·脹·重·痛)이 전혀 유발되지 않도록 하는 것을 원칙으로 하는 침술 방법

- 치통, 두통, 관절통, 심계, 유뇨, 피부소양증, 기침, 천식 등

- 횡격막의 수평선 이상에 증상이 나타나면 손목의 進鍼點을 사용

- 횡격막의 수평선 이하에 증상이 나타나면 발목의 進鍼點을 사용

- 침술을 시술하는 구역과 동일한 進鍼點에 시술

- 현훈, 불면, 도한, 전신소양증과 같이 상하의 구분이 없는 경우는 손목의 進鍼點를 사용

- 進鍼點을 선택한 후 시술 부위의 피부를 소독하고 1.5寸의 호침을 사용하여 피부와 30° 각도로 병변부위가 있는 방향으로 자입

- 피하에 완만한 득기 반응을 느낄 수 있으면 좋음

- 격일에 1회 시술하고 유침은 30분 정도 유지

9) Laser광선 조사요법 (激光穴位照射療法)

- 기존의 침, 뜸 대신 반도체 Laser, He-Ne Laser (cold laser계통. 無痛)를 응용한 것

- 각종 통증 질환, 비염, 피부 질환에 다용

- 시술시 통증이 없으므로 소아에게 활용

- 눈의 손상을 유발하지 않도록 주의, 보호 안경 착용

10) 艾灸療法 (애구요법)

- 艾絨 또는 其他藥物을 體表의 穴位상에 놓고 燒灼, 溫熨 하여 灸火의 熱力을 肌膚에 透入하여 經絡의 作用을 통하여 氣血을 溫通시킴으로써 治療와 保健 目的에 到達하는

일종의 外治法

- 溫散寒邪, 回陽固脫, 活血逐痺, 消結散瘀의 작용
- 中寒陽虛諸症, 大汗淋漓, 四肢厥冷, 脈微欲絶의 虛脫症, 風寒濕痺, 癰瘍初起, 瘰癧, 寒性膿瘍에 사용
- 정기를 회복시키고 면역력을 증강함으로써 질병을 예방하는 작용
- 소아는 피부가 연약하므로 화상이 발생하지 않도록 시술

*직접구(혈자리를 포기할 정도로 생명을 살리고 싶을 때) 간접구 (만성의 경우에)

*뜸의 경제 : 효과와 수가. 파고드는 무면허 쑥찜방

※간호조무사 보조범위 알아두는 것이 임상나가서 큰 도움이 될 것이다!!! 잘 알아두어라!

-아래의 행위는'한의원에서 한의사의 지도·감독하에 간호조무사가 할 수 있는 진료보조 업무의 범위'에 해당

- 가. 한의사가 침을 자입한 후 침병에 전기를 연결하고 자극강도를 조절하는 행위
- 나. 한의사가 시술부위를 지정한 후 지정된 부위에 부항기를 부착하여 건식부항을 시행하는 행위
- 다. 한의사가 시술부위에 자락술을 시술한 후 동 부위에 부항기를 부착하여 습식부항을 시행하는 행위
- 라. 한의사가 뜸을 부착하여야 할 혈위를 지정한 후 그 혈위에 뜸을 부착하는 행위

마. 한의사가 침을 자입한 후 침을 제거하는 행위(발침하는 행위) 건식부항 간접구 전침보조(연결 강도조절) 침구보조(발침)

4. 추나요법

1. 추나요법(推拿療法) ★

1) 효능

- 소아 추나는 그 효과가 체표부터 기리 장부에까지 미친다.
- 신진대사를 촉진하고 정기를 왕성하게 하여 항병능력을 증강

- 직접, 간접적으로 소아의 생체를 정상 생리기능을 회복시키고 환경에 대한 적응력을 기르게 하고 질병을 치료하고 질병을 예방해서 건강한 신체 기르게 한다.
- 소아추나는 광범위하고 그 치료 효과는 비교적 좋다.

2) 적응증

- 感冒감모, 咳嗽해수, 哮喘효천, 기관지 폐렴, 百日咳백일해 등
- 영유아 설사, 소아 복통, 구토, 疳積감적, 便秘변비, 脫肛탈항 등
- 遺尿유뇨, 尿貯留뇨저류 등
- 夜啼야제, 驚厥경궤, 煩燥번조 上氣상기
- 성장발육의 지연, 소아마비 및 뇌염 후유증, 小兒 肌性 斜頸(소아 근육성 사경) 등

3) 추나 시술시 원칙

- ① 有力 : 일정한 힘이 있어야 함
(환자의 체질 병정 병위 부위 등에 따라 적절하게 증감)
- ② 持久 : 지법이 일정 시간 꾸준히 지속되어야 함
(그 시간은 구체적인 정황 따라 결정)
- ③ 均勻 : 동작이 절도 있고 율동성 있게 해야 함
(속도는 빠르지도 느리지도 않아야 하나 가하는 힘이 일정해야)
- ④ 柔和 : 手法가 가볍되 들뜨지 않아야 하고, 무겁되 정체되는 느낌을 줘서는 안 됨, 갑자기 힘을 세게 주거나 거칠게 다루거나 억지로 힘을 쓰면 안 되고 변환 동작이 자연스러워야 함.

4) 추나 상용수법 ★기출

- 按안, 摩마, 掐갑, 揉유, 推추, 運운, 擦찰, 搖요
- 그 외에 拿法(잡을나), 搓法(비빌차), 捏法(반죽할날), 刮法(긁을할), 撮法(모을찰), 扯(揶)法(찢을차), 搗法(찜을도), 滾法(흐를곤) 등

창조의 요건

1. 자유
2. 관찰: 그냥보지말고. 자세히봐라.
3. 디테일
4. 유니크
5. 장인정신
6. 낙관

5. 기타요법

1) 割治療法(할치요법)

- 할치용침, 삼릉침 또는 외과용 메스를 사용하여 경혈이나 특정한 부위의 피부의 조직을 절개하거나 절개한 부위내의 지방을 제거하는 등 국소 부위의 작은 창상을 내서 오랫동안 자극을 주게 하여 치료하는 방법
- 健脾消食, 降逆平喘, 熄風潛陽의 효과
- 疳證, 哮喘의 병증에 주로 사용

2) 埋藏療法(매장요법)

- 경혈 혹은 기타 특정한 부위에 봉합사, 양의 장으로 만든 실, 돼지의 갈기, 동물 내장의 조직 혹은 약물 등을 매립하여 오랫동안 자극을 주게 하여 치료하는 방법
- 매장부위에 따라 치료효과가 다르지만 肅肺平喘, 舒筋通絡, 化痰定痛, 解瘰止痛, 調和氣血 등의 효과
- 氣管支哮喘, 疳證, 腦性麻痺, 脊椎灰白質炎 後遺症, 癲癇, 遺尿에 사용

3) 拍打療法(박타요법)

- 손이나 기구를 사용하여 환아의 사지부위를 세기를 다르게 하여 자극하고 규칙에 따라 두드려서 치료하는 방법
- 본 방법이 최초로 기재된 문헌은 <<易筋經>>
- 溫經通絡, 調和氣血, 行氣止痛, 散瘀消腫, 強筋健骨 등의 효과
- 感冒, 腓 腸 (장딴지) 肌痙攣, 痺症 등의 병증에 사용

4)刮痧療法(갈사요법)

- 蘸 水 또는 식물성 기름을 괄사 기구에 바른 후 직접 또는 간접으로 일정한 부위의 피부에 반복적으로 비비는 방식으로 피부에 자홍색의 반점상의 변화를 일으켜서 치료하는 방법
- 疏暢氣血, 開竅醒腦, 發表清熱, 解毒泄濁, 運脾和胃, 行氣止痛 등의 효과
- 絞腸痧, 中暑, 瘟疫, 感冒 등의 병증에 사용

5) 拔罐療法(발관요법)

- 나무, 유리, 플라스틱 관을 이용하여 관내에 압력을 감소시켜 흡입하여 피부에 부착되는 원리를 이용하여 환부나 혈위상에 부착하여 국소부의 충혈을 일으키고 이에 따라 치료목적을 달성하는 방법
- 火罐法, 水罐法, 針罐法, 藥罐法, 走罐法, 유기관법, 제압관법 등
- 祛 風散寒, 溫經止痛, 行氣活血, 舒筋活絡, 清熱瀉火, 排膿發毒 효과
- 感冒, 肺炎, 腹痛, 腹瀉, 落枕, 瘡癰, 毒蛇咬傷 등의 병증에 사용

6) 日光療法(일광요법) ★

- 일광욕요법을 말하며 체표를 일광 아래에 직접 노출하고 일정한 순서와 시간에 따라 조사의 방향과 부위를 결정하여 시행하며 태양열의 복사작용을 이용하여 질병을 치료하거나 신체를 강화하는 방법
- <<諸病源候論>> “宜時見風日, 若都不見風日, 則令肌膚脆軟, 便易傷損 ... 天和暖無風之時, 令母將抱日中嬉戲, 數見風日, 則血凝氣剛, 肌肉硬密, 堪耐風寒, 不致疾病.”로 제시

광선요법이 핵심치법인 계절성 피부병은? **건선**(겨울에 빛을 못 보면 심해짐)

7) 礦泉療法(광천요법)

- 광천수를 내복하거나 외용으로 사용하여 질병을 예방, 치료하는 방법
- <<山海經>>에서 광천이 질병을 치료하는 것으로 기재
- 發汗祛風, 解肌潤燥, 溫經通絡, 健脾和胃, 滋陰補血, 解毒活血 효과
- 광천의 종류는 다양
- 수온에 따라 冷泉, 微溫泉, 熱泉, 高熱泉 등
- 함유물질에 따라 單純泉, 碳 酸泉, 碱 泉, 食鹽泉, 硫酸鹽泉, 鐵泉, 明礬泉, 硫黃泉 등

8) 音樂療法 : 듣기와 부르기(폐활량, 강심, 듣는노래보다 강한 기운순환)

- 음악의 선율을 이용하여 정신기혈을 조절하여 질병을 치료하도록 촉진하는 방법
 - 怡情悅性, 暢情解鬱, 安神鎮靜, 宣悲開懷, 養心益智, 調暢氣血 효과
 - <<靈樞·邪客>> “天有五音, 人有五臟; 天有六律, 人有六府 ... 此人與天地相應者也.”
- : 음악과 장부의 일정한 관련성을 언급
- 음악은 旋律, 節奏, 節拍, 速度, 力度, 音色, 和聲, 復調調式, 歌詞 등이 다르므로 인체에서 각기 다른 치료 작용

9) 心理療法(심리요법)

- “意療”라고 말하고 情志調節을 응용하여 情緒, 行爲, 精神障礙와 일부 身體의 疾病을 치료하는 방법
- 심신일원론(心身一原論) / 삼인론적 병인론
- 대화 등의 각종 방법을 활용하여 환자의 정신 상태를 변화시키고, 병리 상태를 조절하는 이정변기요법(移精變氣療法)

- 오행의 상생상극이론을 심리치료에 응용하는 오지상승요법(五志相勝療法)

(노희사비공의 상생 상극 이용.)

- 불안의 원인이 되는 자극을 약한 것으로부터 순차적으로 강한 자극을 주어 이들 자극에 익숙해지게 하여 증상을 치료하는 경자평지요법(驚者平之療法)
- 상대에 대한 보증, 설득 등으로 자신을 되찾도록 용기를 주는 지언고론요법(至言高論療法)

*정신과 협업에 회의를 느끼는 상담사와 콜라보.

10) 종합가시광선 (카본 아크 광선조사) 치료

- 각종 원소를 탄소와 같이 연소시켜 발생하는 고유의 파장을 이용하여 치료
- 카본아크에서 발생하는 인공광선은 각 조직에 필요한 에너지를 공급하여 신체의 활성화 및 면역력증가, 비타민D 생성 외에도 다양한 효과
- 야경, 야뇨증(夜尿症), 습진, 양진, 한진, 지루성피부염, 절상, 화상 등 다양한 피부질환과 중이염, 부비동염, 관절질환, 근시, 사시 등 안과질환, 안면신경마비, 통증, 상처의 치료, 腺病質 음낭수종, 탈모 등에 응용
- 각 적응증 별로 탄소봉의 종류를 달리하고, 조사 혈위와 조사 시간을 조작하여 사용
- 조사 혈위는 兩足踝, 兩膝, 咽喉, 腹, 腰를 많이 응용
- 조사 시간은 병변의 부위와 질병의 특성에 따라 달라지는데 아토피 피부염의 경우 부위가 좁으면 집광기를 사용하고 넓으면 그대로 조사
- 급성은 한 부위에 5분, 만성은 한 부위에 10분씩 조사
- 환부가 많으면 만성이라도 처음 2~3일은 한부위에 5분씩 조사하여 1일 조사 시간이 30~40분 정도

수가별 치료법 전망

1.급여

침 약침
뜸
부항

2.비급여

한약
전침
전기물리치료
레이저
초음파

질환별 치료법 전망

1.기질적 질병

진단기기. 기사지휘권 부재
거칠고 투박
가치 편향적 고무줄잣대
참여가 가능하나 보수적 접근필요.

2.기능적 질병

전인미답의 영역
올드이미지가 장수로 혼용되는
한방브랜드파워

치료파워

능동 > 수동
참여 > 제한

한약과 함께 장수를~!

한약 접근성 순위

사상방 - 후세방 - 기성보약.
가치순위는? 좌>우
가치와 비례해서 보상받을 것.

